

· 指南 ·

中国偏头痛中西医结合防治指南（2022 年）

中国中西医结合学会神经科专业委员会

1 前言

偏头痛是临床常见的原发性头痛，以发作性的一侧或双侧中、重度搏动样的头痛为特征，可伴有恶心呕吐、畏光怕声等症状，一般持续 4~72 h。具有反复发作的特点，属于慢性神经血管性疾病^[1]。偏头痛属于中医学“头痛”范畴，是以患者自觉头部疼痛为特征的一种常见病证，另有“脑风”“首风”“头风”“厥头痛”之名^[2]。

偏头痛是影响健康的十大疾病之一，也是全球疾病负担（global burden of disease, GBD）的主要原因^[3]。偏头痛虽然不是致命性疾病，但造成的失能危害，与肢体瘫痪、精神疾病和失智症相当，而且是缺血性脑卒中的潜在危险因素，可与焦虑、抑郁疾病共患。因而，偏头痛需要及时就医并得到控制。

本病多起病于儿童和青春期，中青年期达到发病高峰；患病率 5%~10%，约 60% 的患者有家族史，已发现基因突变（如 MTHFR 基因的 C677T 等）是遗传风险因素；女性多见，约为男性的 2~3 倍。GBD 研究显示偏头痛患病率逐年增加，2019 年时点患病率较 1990 年增加了 1.7%^[4]。但临床存在就诊率不高，预防性治疗比率低和药物镇痛过量的问题，因而提高对偏头痛防治的认识非常重要。

为指导和规范偏头痛的防治，国内于 2016 年发表了《中国偏头痛防治指南》^[5]，2015 年发表了包含偏头痛的《中医临床诊疗指南释义》^[6]。为规范和提高中西医结合防治偏头痛的医疗行为和水平，中国中西医结合学会神经科专业委员会经多次讨论制定了偏头痛中西医结合防治指南。

2 指南的制定方法

2.1 指南制定原则

遵循循证医学原则，在国内外偏头痛相关指南基础上，主要参考国际头痛协会发表的 ICHD-3（International Classification of Headache Disorders,

3rd edition）^[7]，《中国偏头痛防治指南》^[5]，2018 年苏格兰校际指南网络（Scottish Intercollegiate Guidelines Network, SIGN）发表的《偏头痛的药物治疗》^[8]和《中医临床诊疗指南释义》^[6]，结合中西医防治偏头痛的最新研究证据，并依据临床现状和可行性进行制定。

2.2 指南使用者与目标人群

本指南供中国神经科、中医科、中西医结合科、内科、康复科等医务工作者应用。应用目标人群为中国偏头痛患者。

2.3 指南制订工作组

本指南制订工作组由中医专家、中西医结合专家、西医专家、循证医学专家和研究生共同组成。

2.4 文献检索

本指南系统检索 PubMed/Medline、Cochrane Library、中国生物医学文献数据库、万方数据库、中国知网和中文科技期刊全文数据库。循证医学专家进行方法学培训，包括文献检索、文献筛选、证据提取和评价。本指南治疗措施的证据等级依据当前最新研究证据，搜索及引用文献主要为截至 2021 年 12 月 31 日正式发表的系统评价和 Meta 分析。

2.5 证据等级分级标准及推荐强度

遵循循证医学原则，证据等级参照证据评价与推荐意见分级、制定和评价（Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation, GRADE）分级系统^[9]，将证据等级划分为高、中、低和极低 4 个等级（见表 1）。本指南研究证据为系统评价和 Meta 分析，将其视为最高级别证据，根据 GRADE 系统进一步进行证据等级划分，即根据证据中的偏倚风险、不一致性、间接性、不精确性和发表偏倚，将证据质量分为高、中、低和极低等级。

推荐强度参照目前公认和被普遍采用的 GRADE 中的推荐意见，分为强推荐和弱推荐^[10]（见表 2）。本指南证据推荐意见根据证据质量、价值观念与偏好、成本与资源耗费、中西医结合的现状和经验、可行性和可及性等，系统考虑干预措施的利弊平衡，并经临床专家充分讨论达成共识。

通讯作者：高长玉，Tel: 0311-66003942, E-mail: gaochy51@163.com；吴波水，Tel: 021-64088999, E-mail: wbshui@126.com
DOI: 10.7661/j.cjim.20230414.017

表 1 GRADE 证据质量分级与定义

证据质量分级	定义
高 (A)	对观察值非常有把握: 观察值接近真实值
中 (B)	对观察值有中等把握: 观察值有可能接近真实值, 但亦有可能差别很大
低 (C)	对观察值的把握有限: 观察值可能与真实值有较大差别
极低 (D)	对观察值几乎无把握: 观察值与真实值可能有极大差别

表 2 GRADE 推荐强度分级与说明

推荐强度分级	说明	代码
强推荐	明确显示干预措施利大于弊或弊大于利	1
弱推荐	利弊不确定或无论质量高低的证据均显示利弊相当	2

3 中西医结合诊断

采用辨病与辨证相结合的诊断方式。先根据西医偏头痛的诊断标准进行辨病诊断, 再运用中医学理论与方法进行中医辨证诊断。

3.1 辨病诊断及临床分期分型

偏头痛的辨病诊断需要详细的病史询问、完整的神经系统体格检查、必要的影像学及实验室检查, 首先排除颅内器质性疾病。

3.1.1 辨病诊断标准

依据 ICHD-3^[7] 进行诊断, 将偏头痛分为: (1) 无先兆偏头痛; (2) 有先兆偏头痛; (3) 慢性偏头痛; (4) 偏头痛并发症; (5) 很可能的偏头痛; (6) 可能与偏头痛相关的周期综合征。本指南讨论的偏头痛是指无先兆偏头痛和有先兆偏头痛, 其他偏头痛类型不在本指南讨论范围。

(1) 无先兆偏头痛: 其特点是反复头痛, 一次发作持续 4~72 h, 典型表现为单侧、搏动性、中 - 重度头痛, 伴呕吐和 (或) 畏光畏声, 日常体力活动可加剧头痛。其诊断标准: ①符合②~④标准的头痛至少发作 5 次。②头痛发作持续 4~72 h (未治疗或者治疗未成功)。③至少符合下列 4 项中的 2 项: a. 单侧; b. 搏动性; c. 中 - 重度头痛; d. 日常体力活动加重头痛或因头痛而避免日常活动。④发作过程中, 至少符合下列 2 项中的 1 项: a. 恶心和 (或) 呕吐; b. 畏光和畏声。⑤不能用 ICHD-3 中的其他诊断更好地解释。

(2) 有先兆偏头痛: 其特点是反复发作, 持续数分钟的单侧的逐渐出现并完全恢复的视觉、感觉或其他中枢神经系统症状, 通常随之出现偏头痛和相关症状。其诊断标准: ①至少有 2 次发作符合②~③。②至少有 1 个可完全恢复的先兆症状: a. 视觉; b. 感觉; c. 语音和 (或) 语言; d. 运动; e. 脑干; f. 视网膜。③至少符合下列 6 项中的 3 项: a. 至少有 1 个先兆持

续超过 5 min; b. 2 个或更多的症状连续发生; c. 每个独立先兆症状持续 5~60 min; d. 至少有一个先兆是单侧的; e. 至少有一个先兆是阳性的; f. 与先兆伴发或先兆出现 60 min 内出现头痛。④不能用 ICHD-3 中的其他诊断更好地解释。

3.1.2 临床分期

偏头痛临床分为急性发作期和缓解期。急性发作期持续 4~72 h, 急性发作期后是头痛缓解期, 缓解期可为数天至数年。

3.1.3 头痛严重程度分级

分为无、轻度、中度和重度疼痛^[7]。头痛严重程度评估常用视觉模拟评分法 (Visual Analogue Scale/Score, VAS), 即: 无头痛: (VAS, 0~4 mm); 轻度疼痛: 不干扰日常活动 (VAS, 5~44 mm); 中度疼痛: 抑制但不完全阻止日常活动 (VAS, 45~75 mm); 重度疼痛: 妨碍所有活动 (VAS, 75~100 mm)。

3.2 辨证诊断

参考《中医临床诊疗指南释义》^[6]《中医内科学》^[2]《实用中西医结合神经病学》^[11], 并根据治疗偏头痛有效方药的临床研究确定常见证型为风瘀阻络证、肝阳上亢证、风痰上扰证及瘀血阻络证。临床上, 也会出现常见证型的兼证。

(1) 风瘀阻络证: 多由感受风邪而诱发, 表现为突发头痛, 程度较剧, 呈跳痛或掣痛; 多位于前额、颞部, 或双侧交替性疼痛; 舌质暗淡或暗红, 舌苔薄白, 脉弦或紧。

(2) 肝阳上亢证: 常因情志过激、劳累过度等诱发; 可先有暗点、闪光等先兆, 继而出现剧烈头痛, 呈跳痛或胀痛, 头痛部位多一侧尤甚, 面红目赤, 眼目抽痛, 心烦易怒, 夜眠不宁; 或伴有恶心、呕吐; 舌质红, 苔薄黄或少苔, 脉弦或弦数。

(3) 风痰上扰证: 常因情志不遂, 劳逸过度或饮食不节等诱发, 表现为突发头痛, 程度较剧, 呈昏痛或胀痛, 头重如裹, 多为两侧, 胸脘满闷, 或伴有恶心, 呕吐痰涎; 舌质淡红, 或舌胖大, 舌苔白腻或黄腻, 脉弦或滑。

(4) 瘀血阻络证: 多为病程日久、头痛反复、经久不愈者。头痛如锥刺, 程度较剧, 固定不移, 入夜尤甚, 可一侧或两侧颞部疼痛, 患者面色晦滞, 妇女行经色暗或夹血块, 舌质紫暗或见瘀斑, 脉细或涩。

4 中西医结合防治

偏头痛的防治目的是终止或减轻头痛, 缓解伴发症状, 预防头痛发作。中西医结合防治包含健康宣教、中医和中西医结合治疗、西医治疗、心理和行为治疗。

治疗分为急性期治疗和预防性治疗, 通常需要急性期治疗和预防性治疗相结合。

4.1 偏头痛缓解期的预防性治疗

4.1.1 预防性治疗的目的

降低发作频率、减轻发作程度、减少失能、提高急性发作期的治疗效果^[12]。

4.1.2 预防性治疗的有效性判定

有效指标包括偏头痛发作频率、头痛持续时间、头痛程度、头痛的功能损害程度以及急性发作期对治疗的反应。在临床试验中, 通常偏头痛严重程度和(或)频率降低 30%~50% 判定为有效。

4.1.3 预防性治疗的指征

存在以下情况应考虑预防性治疗:(1) 患者的生活质量、工作和学业严重受损(需根据患者本人判断);(2) 每月发作频率 2 次以上;(3) 急性期药物治疗无效或患者无法耐受;(4) 存在频繁、长时间或令患者极度不适的先兆, 或为偏头痛性脑梗死、偏瘫性偏头痛、伴有脑干先兆偏头痛等;(5) 连续 2 个月, 每月使用急性期治疗 6~8 次以上;(6) 偏头痛发作持续 72 h 以上等^[13]。

4.1.4 缓解期的中医和中西医结合预防性治疗

4.1.4.1 中药和中西医结合治疗

主要参考《中医临床诊疗指南释义》^[6]《中医内科学》^[2]和《实用中西医结合神经病学》^[11]以及已发表的系统评价和 Meta 分析。鉴于已有文献中偏头痛的临床研究多是辨病治疗, 本指南中的辨证论治方药根据方药的功效归类于相应的证型下, 便于读者参考采用。

(1) 风瘀阻络证, 治法: 疏风散邪、活血止痛。

①推荐意见 1: 川芎茶调散, 每日 1 剂, 分、早晚 2 次口服。(1B)

证据描述: Meta 分析(36 项 RCT, 3 309 例)^[13]显示川芎茶调散单用(OR 4.31, 95% CI : 3.34~5.56)或联合西药(OR 4.30, 95% CI : 3.09~6.00)总有效率优于西药组, 能减少头痛发作次数, 降低头痛 VAS 评分, 缩短头痛持续时间。

②推荐意见 2: 散偏汤, 每日 1 剂, 分早晚 2 次口服。(1B)

证据描述: Meta 分析(10 项 RCT, 776 例)^[14]显示, 散偏汤治疗偏头痛的疗效优于西药(氟桂利嗪为主), 能缓解疼痛及降低疼痛积分(RR 1.23, 95% CI : 1.14~1.31), 且安全性较好。

③推荐意见 3: 都梁软胶囊, 每日 3 次, 每次 3 粒, 口服。(1B)

证据描述: Meta 分析^[15]显示都梁软胶囊联合西药(8 项 RCT, 656 例)治疗偏头痛的总有效率优于西药(RR 1.20, 95% CI : 1.13~1.28), 单用都梁软胶囊(4 项 RCT, 492 例)的有效率优于氟桂利嗪(RR 1.13, 95% CI : 1.02~1.25), 安全性较高。

④推荐意见 4: 正天丸, 每日 3 次, 每次 6 g, 口服。(1B)

证据描述: 系统评价(15 项 RCT, 956 例)^[16]显示正天丸联合尼莫地平的总有效率(RR 1.44, 95% CI : 1.2~1.74)或联合氟桂利嗪的总有效率(RR 1.21, 95% CI : 1.08~1.35)均优于对照组; 正天丸的总有效率优于模拟剂(RR 2.5, 95% CI : 1.83~3.41), 并在偏头痛持续时间、发作次数、发作程度、改善伴随症状方面优于对照组。

⑤推荐意见 5: 通天口服液, 每日 3 次, 每次 10 mL, 口服。(1B)

证据描述: Meta 分析(14 项 RCT, 1 215 例)^[17]显示通天口服液单用(OR 1.53, 95% CI : 1.14~2.04)或联合钙拮抗剂(OR 3.67, 95% CI : 2.03~6.64)治疗偏头痛的显效率高于单用钙拮抗剂, 且未增加不良反应。

⑥推荐意见 6: 川芎清脑颗粒, 每日 3 次, 每次 5~10 g, 口服。(1B)

证据描述: Meta 分析(11 项 RCT, 883 例)^[18]显示川芎清脑颗粒联合氟桂利嗪治疗偏头痛的有效率优于氟桂利嗪(RR 1.20, 95% CI : 1.13~1.28), 可降低头痛 VAS 评分, 未增加不良反应发生率。

(2) 肝阳上亢证, 治法: 平肝息风, 活血止痛。

①推荐意见 7: 天麻钩藤饮, 每日 1 剂, 分早晚 2 次口服。(1B)

证据描述: Meta 分析(10 项 RCT, 900 例)^[19]显示天麻钩藤饮治疗偏头痛的总有效率较对照组(钙通道阻滞剂)增加 31%(RR 1.31, 95% CI : 1.22~1.40)。另一项 Meta 分析(12 项 RCT, 1 373 例)^[20]显示天麻钩藤饮或其加减方单用或联合西药治疗肝阳上亢型偏头痛的总有效率优于西药对照组(OR 4.23, 95% CI : 3.04~5.87)。

②推荐意见 8: 天舒胶囊, 每日 3 次, 每次 4 粒, 口服。(1B)

证据描述: 系统评价(20 项 RCT, 1 807 例)^[21]显示天舒胶囊(单用或联合氟桂利嗪)治疗偏头痛的有效率优于对照组(OR 3.60, 95% CI : 2.65~4.90), 并减少头痛持续时间和发作频率。Meta 分析(13 项 RCT, 1 073 例)^[22]显示天舒胶囊联合氟桂

利嗪治疗偏头痛的总有效率优于氟桂利嗪 (OR 3.52, 95% CI : 2.51~4.95)。

③推荐意见 9: 养血清脑颗粒, 每日 3 次, 每次 4 g, 口服。(1B)

证据描述: 系统评价 (23 项 RCT, 2 308 例)^[23] 显示, 养血清脑颗粒联合钙通道阻滞剂治疗偏头痛的有效率优于钙通道阻滞剂 (RR 1.24, 95% CI : 1.17~1.32)。并降低头痛频率和程度、减少头痛持续时间。

④推荐意见 10: 丹珍头痛胶囊, 每日 3 次, 每次 3 粒, 口服。(2C)

证据描述: Meta 分析^[24] (9 项 RCT, 891 例) 显示丹珍头痛胶囊 (单用或联合西药) 治疗偏头痛的总有效率优于西药对照组 (RR 1.26, 95% CI : 1.19~1.35), 未见明显不良反应。

(3) 风痰上扰证, 治法: 化痰息风, 通络止痛。

①推荐意见 11: 头痛宁胶囊, 每日 3 次, 每次 3 粒, 口服。(1B)

证据描述: Meta 分析 (16 项 RCT, 2 228 例)^[25] 显示头痛宁胶囊治疗偏头痛的有效率优于对照组 (OR 3.29, 95% CI : 2.56~4.24), 不良反应发生率较低。

(4) 瘀血阻络证, 治法: 活血化瘀、通络止痛。

①推荐意见 12: 通窍活血汤, 每日 1 剂, 分早、晚 2 次口服。(2C)

证据描述: 系统评价 (15 项 RCT, 1 367 例)^[26] 显示通窍活血汤缓解头痛的疗效优于西药 (RR 1.36, 95% CI : 1.28~1.43), 且不良反应少。

②推荐意见 13: 血府逐瘀汤, 每日 1 剂, 分早晚 2 次口服。(2C)

证据描述: Meta 分析 (12 项 RCT, 573 例)^[27] 显示血府逐瘀汤治疗偏头痛的总体疗效 (OR 4.54, 95% CI : 3.06~6.73) 及治愈率 (OR 2.96, 95% CI : 2.18~4.01) 均优于西药。

③推荐意见 14: 通心络胶囊, 每日 3 次, 每次 3 粒, 口服。(1B)

证据描述: Meta 分析 (10 项 RCT, 770 例)^[28] 显示通心络胶囊或联合氟桂利嗪治疗偏头痛的有效率优于单用氟桂利嗪 (RR 1.18, 95% CI : 1.05~1.33), 能减少发作次数, 缩短头痛持续时间。

4.1.4.2 针灸治疗

推荐意见 15: 针灸治疗, 缓解期每 1~2 日针刺 1 次, 急性发作期间每日针刺 1~2 次。(2C)

证据描述: Meta 分析 (62 项 RCT, 4 947 例)^[29] 显示针刺治疗偏头痛 1 个月降低 VAS 评分优于假针

刺 (MD -1.56, 95% CI : -2.21~-0.92) 和药物组 (MD -1.22, 95% CI : -1.57~-0.87)。但不同的 Meta 分析对针灸治疗偏头痛的疗效评价结果稍有不同。

4.1.5 缓解期西医预防性治疗

4.1.5.1 西药治疗

(1) β 受体阻滞剂

推荐意见 16: 普萘洛尔 40~160 mg/d, 口服 (1A)。美托洛尔 50~100 mg/d, 口服 (1A)。阿替洛尔 50~100 mg/d, 口服。(1A)

证据描述: 普萘洛尔 (80~160 mg/d) 在降低 50% 偏头痛发生频率方面优于安慰剂 (RR 1.4, 95% CI : 1.1~1.7), 同样有效的 β 受体阻滞剂还包括了阿替洛尔 (RR 1.8, 95% CI : 1.0~3.2) 和美托洛尔 (RR 1.9, 95% CI : 1.3~2.8)^[30]。不良反应多见眩晕和疲劳, 但有心脏抑制、减慢心率等作用; 伴有心力衰竭及支气管哮喘等患者禁用。

(2) 钙通道阻滞剂

推荐意见 17: 氟桂利嗪 5~10 mg/d, 口服。(1B)

证据描述: Meta 分析 (5 项 RCT, 249 例)^[31] 显示氟桂利嗪 10 mg 可减少头痛发作 (MD 20.4, 95% CI : -0.61~-0.26)。不良反应有镇静和增加体重, 另有锥体外系和抑郁不良反应。其他钙通道阻滞剂的疗效尚不确定。

(3) 血管紧张素受体拮抗剂

推荐意见 18: 坎地沙坦 16 mg/d, 口服。(1A)

证据描述: 坎地沙坦预防偏头痛有效^[32], 能降低发作频率 50% 以上; 16 mg 坎地沙坦与 160 mg 普萘洛尔疗效相似。Meta 分析 (11 项 RCT, 940 例)^[33] 显示坎地沙坦预防偏头痛的有效率优于对照组 (主要为氟桂利嗪, OR 3.17, 95% CI : 2.06~4.87)。不良反应包括头晕、疲劳和感觉异常。

(4) 抗癫痫药物

①推荐意见 19: 托吡酯 25~100 mg/d, 口服。(1A)

证据描述: 不同剂量托吡酯 [50 mg (OR 2.63, 95% CI : 0.22~30.93), 100 mg (OR 3.27, 95% CI : 1.72~6.23), 200 mg (OR 2.35, 95% CI : 1.33~4.18)] 预防偏头痛均有效, 综合效应值为 2.70 (95% CI : 1.97~3.69)^[34]。托吡酯 100 mg 和 200 mg 的效果优于 50 mg, 但不良事件发生率增高。常见不良反应包括恶心、感觉异常、厌食和体重减轻, 另外有认知不良、抑郁症, 孕期和哺乳期服用有致婴儿口腔发育异常风险^[35]。

②推荐意见 20: 丙戊酸钠 400~1 000 mg/d, 口服。(1B)

证据描述: Meta 分析 (7 项 RCT, 782 例)^[36] 显示丙戊酸钠预防偏头痛的有效率优于安慰剂 (OR 4.02, 95% CI : 2.17~7.44), 和其他治疗药物 (包括托吡酯、左乙拉西坦) 相比疗效差异无统计学意义。不良反应轻微但常见, 包括疲劳、头晕、震颤和体重增加, 孕妇服用有胎儿致畸风险^[37, 38]。

③推荐意见 21: 左乙拉西坦 500~1 000 mg/d, 口服。(2B)

证据描述: Meta 分析 (9 项 RCT, 215 例)^[39] 显示左乙拉西坦可以减少头痛发作频率, 与基线比较用药 1、3、6 个月的汇总平均差分别是 -3.02 (95% CI : -4.59~-1.45)、-4.65 (95% CI : -7~-2.3) 和 -5.71 (95% CI : -8.60~-2.82)。常见不良反应包括嗜睡、头晕和行为异常, 但通常不需要停药^[40]。

(4) 三环类抗抑郁药

推荐意见 22: 阿米替林 25~75 mg/d, 口服。(1A)

证据描述: Meta 分析显示三环类抗抑郁药 (主要是阿米替林) 与安慰剂组比较可以减少偏头痛发作次数 (SMD -0.70, 95% CI : -0.93~-0.48), 其疗效随治疗时间的延长而增加, 且 50% 效应率优于安慰剂 (RR 1.80, 95% CI : 1.24~2.62), 在高头痛频率的患者中效果更明显^[41]。不良反应常见口干和嗜睡。

(5) 降钙素基因相关肽 (calcitonin gene related peptide, CGRP) 单克隆抗体

推荐意见 23: 瑞玛奈珠单抗 225 mg/月或 675 mg/季度, 皮下注射 (1A)。伽奈珠单抗 120 mg/月, 首月 240 mg, 皮下注射 (1A)。厄锐努单抗 70 mg/月或 140 mg/月, 皮下注射 (1A)。艾普奈珠单抗 100 mg/季度或 300 mg/季度, 静脉注射 (1A)。

证据描述: CGRP 单克隆抗体通过阻断 CGRP 与受体的结合而发挥作用。Meta 分析 (18 项 RCT, 8 926 例)^[42] 显示 CGRP 单克隆抗体预防偏头痛有效, 与安慰剂比较, 瑞玛奈珠单抗 (Fremanezumab, MD -2.19, 95% CI : -3.15~-1.25)、伽奈珠单抗 (galcanezumab, MD -2.10, 95% CI : -2.76~-1.45)、厄锐努单抗 (erenumab, MD -1.61, 95% CI : -2.40~-0.84)、艾普奈珠单抗 (eptinezumab, MD -1.43, 95% CI : -2.59~-0.36) 均能有效减少每月偏头痛天数。CGRP 单克隆抗体的不良反应少^[43]。

(6) 肉毒杆菌毒素 A

推荐意见 24: 发作频繁且药物治疗效果差或不能耐受药物者可选择肉毒杆菌毒素 A 预防性治疗偏头痛。(2B)

证据描述: 肉毒杆菌毒素 A 注射可预防偏头痛^[44]。

常见的不良反应有上睑下垂、肌肉无力、注射部位疼痛等, 但症状轻微、短暂、可逆^[44, 45]。

4.1.5.2 其他治疗

推荐意见 25: 发作频繁且药物治疗效果差或不能耐受药物者可选择枕大神经阻滞 (2B) 或高频重复经颅磁刺激 (2C) 预防性治疗偏头痛。

证据描述: Meta 分析显示枕大神经阻滞可以降低偏头痛发作频率和严重程度, 减少头痛天数^[46]。高频 (10 Hz) 重复经颅磁刺激 (repetitive transcranial magnetic stimulation, rTMS) 刺激初级运动皮质可有效预防偏头痛^[47]。

4.1.6 缓解期中西医方案的选择和疗程

中医、西医方法预防偏头痛均有较好的疗效。中医、西医哪种药物更有效的循证证据少, 因而, 在推荐的有效药物中首先选择哪种预防性药物取决于药物的有效性证据、患者合并症、其他危险因素、药物相互作用、医生的经验和患者偏好。无证据显示中药联合或与西药联合优于单用, 单纯西药或中药无效者可以采用中西药联合应用。

预防药物从低剂量开始, 逐渐增加至最小有效剂量; 在决定药物是否有效之前, 应以最大耐受剂量至少使用 3 个月。有效的预防性治疗需要持续约 6 个月, 之后缓慢减量或停药。若头痛发作再次频繁, 可重新使用原先有效的药物。对于超说明书的应用研究证据的选择, 需要根据辨证结果结合药物说明书的作用并征求患者的意愿决定是否应用。患者长期用药需要注意防止不良反应的发生。

4.2 偏头痛急性发作期治疗

4.2.1 急性期治疗的目的

中止偏头痛发作, 减少头痛严重程度和伴发症状。

4.2.2 急性期治疗的有效性判定

治疗有效以服药后 2 h 无疼痛和 24 h 持续无疼痛作为判定标准^[8, 12]。研究中多以疼痛缓解为标准, 指疼痛从重度/中度到轻度/无疼痛, 或 VAS 疼痛评分下降 50% 以上。

4.2.3 急性期治疗的指征

一旦患者偏头痛发作, 应立即进行治疗。对于有先兆的患者, 建议在头痛开始时服用药物 (如曲坦类), 而不是先兆开始时服用 (除非先兆和头痛同时开始)。

4.2.4 急性期的中医和中西医结合治疗

4.2.4.1 中药和中西医结合治疗

推荐意见 26: 建议根据不同的辨证结果个体化用药, 可参考缓解期的中医和中西医结合预防治疗。这

些推荐基于专家共识,临床需结合药物说明书并征求患者的意愿决定是否应用。

证据描述:中药和中西医结合治疗偏头痛急性期的临床研究极少,尚无相应的研究证据。针对偏头痛缓解期的中药和中西医结合预防性研究涵盖了急性发作期。这些研究结果表明缓解期的中药和中西医结合治疗能够应用于偏头痛急性期。

4.2.4.2 针灸治疗

推荐意见 27:针灸可用于偏头痛急性期治疗。(2C)

证据描述:Meta 分析(5 项 RCT, 618 例)^[48]显示针刺后 2 h (MD 0.36, 95% CI : 0.08~0.65) 和 4 h (MD 0.49, 95% CI : 0.14~0.84) 的 VAS 疼痛评分减少值优于假针刺组。

4.2.5 急性期的西医治疗

4.2.5.1 非特异性镇痛药物

(1) 非甾体类抗炎药

推荐意见 28:阿司匹林 300~1 000 mg, 口服(1A)。萘普生 500 mg 或 825 mg, 口服(1A)。双氯芬酸钾 50~100 mg, 口服(1A)。布洛芬 200~400 mg, 口服(1B)。对乙酰氨基酚 1 000 mg, 口服(1B)。

证据描述:多项系统评价显示与安慰剂比较,非甾体类抗炎药(阿司匹林、布洛芬、萘普生、双氯芬酸钾、对乙酰氨基酚)治疗急性偏头痛发作有效^[49-53]。阿司匹林、布洛芬服药后 2 h 能显著缓解头痛并维持 24 h, 还能缓解恶心、畏光、畏声症状,布洛芬 400 mg 优于 200 mg^[49, 50]。萘普生和双氯芬酸钾服药后 2 h 能有效缓解头痛^[51, 52]。对乙酰氨基酚在 2 h 内无头痛和维持 24 h 无头痛方面优于安慰剂^[53]。长期使用非甾体抗炎药可导致胃肠道溃疡或出血,可能使哮喘恶化。因为有患瑞氏综合征(Reye's syndrome)的风险,阿司匹林不应用于 16 岁以下的患者和孕妇。

(2) 止吐剂

推荐意见 29:甲氧氯普胺 10 mg, 口服。(2B)

证据描述:甲氧氯普胺 10 mg (口服)联合阿司匹林 900 mg 或对乙酰氨基酚 1 000 mg 的疗效与 100 mg 舒马曲坦相似,对减少呕吐有益^[49, 53]。但有静坐不能、嗜睡和头晕等不良反应。

4.2.5.2 特异性镇痛药物

(1) 麦角胺类药物

推荐意见 30:Trudhesa (DHE) 鼻喷雾剂 1.45 mg, 喷鼻。(2A)

证据描述:多项临床研究显示二氢麦角胺(dihydroergotamine, DHE)治疗偏头痛急性发作有

效,在 2 h 内无疼痛和改善伴随症状方面均优于安慰剂^[54, 55]。DHE 有多种剂型,DHE 药物-器械组合产品 Rudhesa (DHE) 鼻喷雾剂于 2021 年被美国 FDA 批准用于治疗急性偏头痛。DHE 可引起动脉血管收缩,有心血管危险因素的患者应慎用,孕妇应禁用,哺乳期不建议使用^[56]。

(2) 曲坦类药物

推荐意见 31:舒马曲坦 25~100 mg, 口服;5~20 mg, 鼻喷雾剂;6 mg, 皮下注射(1A)。佐米曲坦 2.5~5 mg, 口服;2.5~5 mg, 鼻喷雾剂(1A)。利扎曲坦 5~10 mg, 口服(1A)。阿莫曲坦 12.5 mg, 口服(1A)。依立曲坦 40 mg, 口服(1A)。

证据描述:曲坦类药物在 2 h 止痛、24 h 持续止痛方面优于安慰剂^[57-61]。曲坦类药物第一代为舒马曲坦,第二代有佐米曲坦、阿莫曲坦、利扎曲坦、依立曲坦等。曲坦类药物有多种剂型,尽早用药可显著提高疗效,疗效不足与头痛严重程度、畏光怕声、恶心和抑郁相关^[58]。舒马曲坦和萘普生的联合治疗优于安慰剂或单药治疗,不良反应更常见但轻微^[59]。曲坦类药物的不良反应轻微且短暂,但需警惕严重心血管事件的发生^[62]。舒马曲坦鼻内用药增加味觉障碍风险^[63],利扎曲坦和普萘洛尔联用时的最大剂量为 5 mg,且不能在普萘洛尔服用后 2 h 以内服用。

(3) 拉米地坦

推荐意见 32:拉米地坦 50 mg 或 100 mg 或 200 mg, 口服。(1A)

证据描述:不同剂量的拉米地坦治疗偏头痛急性发作都有效且安全 50 mg (RR 1.38, 95% CI : 1.13~1.68)、100 mg (RR 1.63, 95% CI : 1.40~1.91)、200 mg (RR 1.96, 95% CI : 1.69~2.27)^[64]。拉米地坦 200 mg 比 100 mg 更有效^[65],可实现 2 h 无痛和 24 h 持续无痛^[66]。其头晕、恶心、疲劳、感觉异常和嗜睡等不良反应的发生率高^[67]。

(4) 降钙素基因相关肽受体拮抗剂(calcitonin gene-related peptide receptor antagonists, Gepants)

推荐意见 33:瑞美吉泮 75 mg, 口腔崩解剂(1A)。乌布吉泮 50 mg 或 100 mg, 口腔崩解剂(1A)。

证据描述:Gepants 治疗偏头痛急性发作有很多高质量研究证据^[68-71],Gepants 在偏头痛患者给药后 2 h 无痛(OR 2.11, 95% CI : 1.90~2.35)和头痛减轻(OR 1.94, 95% CI : 1.70~2.21)方面明显优于安慰剂^[68],不良反应轻,常见恶心^[70]。乌布吉泮(商品名 UBRELVY)和瑞美吉泮(商品名 Nurtec)是两种新型 Gepants 制剂,被美国 FDA 批准用于偏头痛

急性治疗。

4.2.5.3 其他治疗

推荐意见 34: 药物治疗效果差或不能耐受药物者可选择无创迷走神经刺激 (noninvasive vagus nerve stimulation, nVNS) 用于偏头痛急性期治疗。(2B)

证据描述: 2018 年 FDA 已批准无创迷走神经刺激 (noninvasive vagus nerve stimulation, nVNS) 装置 GammaCore 用于治疗偏头痛急性期, nVNS 可以增加 30 min 和 60 min 内无头痛率, 减少头痛急救药物的使用; 其不良反应轻微, 包括颈部抽搐、刺耳声音和刺激部位发红^[72]。

4.2.6 急性期中西医方案的选择和疗程

轻度头痛患者可选择非特异性镇痛西药, 也可辨证选择中药或针灸治疗。中度头痛患者可采用中西医结合的方式, 有利于提高疗效。重度头痛患者, 可采用特异性镇痛西药治疗, 应用受到限制时可应用非特异性镇痛药物联合中药和针灸治疗。

急性期治疗在偏头痛出现时即给予一次药物, 如果疗效不充分, 2 h 后可根据症状和药物特点重复相同或不同的治疗。偏头痛急性期的有效药物指急性期偏头痛治疗有效, 且疗效具有可重复性, 3 次发作中有 2 次以上有效^[13]。具体药物的选择要考虑患者的有效药物和意愿。

4.3 健康宣教

(1) 通过健康宣教, 正确认识疾病, 了解偏头痛发作和加重的诱因, 树立正确的防治观念和目標。

(2) 保持健康的生活方式, 调畅情志, 避免诱发和加重头痛的诱因, 如酒和含咖啡因、酪氨酸及亚硝酸盐的食物, 寒冷、酷热、噪音、强光等环境。

(3) 在医生指导下, 建立个体化的急性期治疗方案和缓解期预防方案, 避免过度使用镇痛药物。

4.4 心理行为治疗

偏头痛的心理治疗主要基于行为治疗, 包括放松训练、生物反馈及认知行为治疗。

中西医各有优势, 西医药对偏头痛尤其是急性期重度头痛患者疗效较好, 但有些药物有明显不良反应, 有的患者应用受限。中医药对偏头痛尤其预防性治疗有较好疗效, 且不良反应较少。但目前中医药治疗偏头痛的 RCT 研究存在方法学和疗效指标质量不高的问题, 对系统评价和 Meta 分析结论的客观性有一定影响, 针对偏头痛急性期的 RCT 研究少, 有待于今后进行符合中医药规律的循证医学研究。中西医是不同的理论体系, 各有所长, 中西医结合治疗可进一步提高疗效, 但仍有待于深入开展临床研究, 总结

出治疗和预防偏头痛的理想方法。

5 指南的发布、传播与更新

指南将在学术期刊发表, 发布后将以学术会议等形式进行传播, 促进在临床上的使用, 使其能更好指导临床实践。工作组计划每 4~5 年对指南进行更新。

利益冲突: 本指南制订过程中, 所有参与本指南的专家和工作组成员与医药企业不存在指南相关的利益冲突。

专家委员会:

执笔人: 张云云 (上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院)、吴波水 (复旦大学附属华山医院)、刘毅 (上海市中医医院)

专家委员会成员 (按姓氏笔画排序):

中医专家: 于涛 (天津中医药大学第一附属医院)、王忞东 (上海浦东新区中医医院)、过伟峰 (南京中医药大学)、刘毅 (上海市中医医院)、杨文明 (安徽中医药大学第一附属医院)、杨添淞 (黑龙江中医药大学附属第一医院)、张兰坤 (南京中医药大学第二附属医院)、陈卫银 (成都中医药大学附属医院)、陈志刚 (北京中医药大学东方医院)、林海 (西安市中医医院)、饶旺福 (江西中医药大学)、曹晓岚 (山东中医药大学附属医院)

中西医结合专家: 马云枝 (河南中医药大学第一附属医院)、古联 (广西中医药大学第一附属医院)、杜宝新 (广东省中医院)、吴成翰 (福建中医药大学附属第二人民医院)、吴波水 (复旦大学附属华山医院)、况时祥 (贵州中医药大学第二附属医院)、张云云 (上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院)、周洋 (上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院)、侯群 (浙江省中医院)、项宝玉 (中国中医科学院附属西苑医院)、高长玉 (河北医科大学第二医院)、樊萍 (江西省中西医结合医院)

西医专家: 王志红 (河北医科大学第二医院)、张成 (中山大学附属第一医院)、林友榆 (晋江市医院)、罗玉敏 (首都医科大学宣武医院)、洪铭范 (广东药科大学附属第一医院)、徐平 (遵义医科大学附属医院)、高燕军 (承德医学院附属医院)、彭英 (中山大学孙逸仙纪念医院神经内科)、谢涛 (河北医科大学第二医院)、熊友生 (南昌大学第二附属医院)

循证医学专家: 张云云 (上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院)

秘书组: 韦紫君 (上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院)、张月婵 (上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院)